

임상검사 결과보고서

LABORATORY TEST REPORT — 서울중앙종합병원 진단검사의학과

검사의뢰번호 L26-0731-88413

보고일시 2026-07-31 22:41

보고구분 응급 (STAT) / 최종보고

환자명	박서준	등록번호	01847392	성별/나이	M / 58	의뢰과	응급의학과
채혈일시	2026-07-31 22:05	접수일시	2026-07-31 22:12	검체종류	Whole blood / Serum	의뢰의	정우성
검체상태	적합 (용혈·황달·지혈증 없음)	검사장비	XN-3000 / cobas 8000	검사자	임상병리사 오세영	판독의	진단검사의학과 문지호

I. 일반혈액검사 (Complete Blood Count with Differential)

검사항목	결과	F	단위	참고치	이전결과	Δ / 비고
White Blood Cell (WBC)	13.4	H	10 ³ /μL	4.0 – 10.0	8.2 (2026-05-14)	▲ 5.2
Red Blood Cell (RBC)	4.62		10 ⁶ /μL	4.20 – 5.80	4.71	—
Hemoglobin (Hb)	14.1		g/dL	13.0 – 17.0	14.4	—
Hematocrit (Hct)	42.3		%	39.0 – 52.0	43.1	—
MCV	91.6		fL	80.0 – 100.0	91.5	—
MCH	30.5		pg	27.0 – 34.0	30.6	—
MCHC	33.3		g/dL	32.0 – 36.0	33.4	—
RDW-CV	13.1		%	11.5 – 14.5	12.9	—
Platelet (PLT)	246		10 ³ /μL	150 – 400	238	—
Neutrophil (Seg)	82.4	H	%	40.0 – 75.0	61.2	▲ 21.2
Lymphocyte	11.8	L	%	20.0 – 44.0	28.5	▼ 16.7
Monocyte	4.6		%	2.0 – 9.0	7.1	—
Eosinophil	0.9		%	0.0 – 5.0	2.6	—
Basophil	0.3		%	0.0 – 2.0	0.6	—
ANC (절대호중구수)	11,042	H	/μL	1,800 – 7,500	5,018	계산값

II. 혈청 화학검사 (Serum Chemistry)

검사항목	결과	F	단위	참고치	이전결과	Δ / 비고
Glucose (random)	168	H	mg/dL	70 – 140	131	비공복
Blood Urea Nitrogen	18.4		mg/dL	8.0 – 23.0	16.2	—
Creatinine	1.06		mg/dL	0.70 – 1.30	0.98	—
eGFR (CKD-EPI 2021)	78		mL/min/1.73m ²	≥ 60	84	계산값
Sodium (Na)	138		mmol/L	135 – 145	140	—
Potassium (K)	4.1		mmol/L	3.5 – 5.1	4.3	—
Chloride (Cl)	102		mmol/L	98 – 110	103	—
Total CO ₂	20.1	L	mmol/L	22.0 – 29.0	24.6	▼ 4.5
Total Protein	6.9		g/dL	6.4 – 8.3	7.1	—
Albumin	4.0		g/dL	3.5 – 5.2	4.2	—
AST (SGOT)	86	H	IU/L	0 – 40	28	▲ 58
ALT (SGPT)	38		IU/L	0 – 41	31	—
Total Bilirubin	0.8		mg/dL	0.2 – 1.2	0.7	—
LDH	412	H	IU/L	140 – 271	186	▲ 226
HbA1c (NGSP)	7.4	H	%	4.0 – 6.0	7.1 (2026-05-14)	당뇨 조절 미흡
Total Cholesterol	218	H	mg/dL	< 200	204	—
LDL-Cholesterol	142	H	mg/dL	< 100 (고위험군)	128	직접측정법
HDL-Cholesterol	34	L	mg/dL	> 40	38	—
Triglyceride	246	H	mg/dL	< 150	198	비공복 채혈

III. 심근효소 및 응고검사 (Cardiac Markers & Coagulation)

검사항목	결과	F	단위	참고치	재검 (22:05→01:10)	임상적 의의
hs-Troponin I	1,842.6	H	ng/L	< 34.2 (남성)	4,120.8	급격한 상승, 심근손상 시사
CK	642	H	IU/L	55 – 170	1,108	—
CK-MB	58.4	H	ng/mL	0.0 – 5.0	92.1	—
Myoglobin	386	H	ng/mL	28 – 72	—	—
NT-proBNP	1,284	H	pg/mL	< 125	—	심실펙 부하 증가
D-dimer	0.42		μg/mL FEU	< 0.50	—	폐색전증 가능성 낮음
PT (INR)	1.08		INR	0.80 – 1.20	—	—
PT (sec)	12.4		sec	10.4 – 13.6	—	—
aPTT	31.2		sec	26.0 – 38.0	—	—
Fibrinogen	368		mg/dL	200 – 400	—	—

IV. 동맥혈 가스분석 (Arterial Blood Gas, room air → O₂ 3L)

검사항목	결과	F	단위	참고치	채취부위	비고
pH	7.318	L	—	7.350 – 7.450	우측 요골동맥	경도 산증
pCO ₂	38.6		mmHg	35.0 – 45.0	우측 요골동맥	—
pO ₂	68.2	L	mmHg	80.0 – 100.0	우측 요골동맥	room air 상태

HCO ₃ ⁻	19.4	L	mmol/L	22.0 – 26.0	—	계산값
Base Excess	-5.2	L	mmol/L	-2.0 – +2.0	—	—
Lactate	3.8	H	mmol/L	0.5 – 2.2	—	조직 저관류 시사
SaO ₂	93.1	L	%	95.0 – 100.0	—	—

[진단검사의학과 판독 소견]						
1. hs-Troponin I가 초기 1,842.6 ng/L에서 3시간 후 재검 시 4,120.8 ng/L로 유의하게 상승하였으며, CK-MB 및 Myoglobin의 동반 상승 소견을 보임. 급성 심근손상(acute myocardial injury)에 합당한 패턴임.						
2. 백혈구 증가 및 호중구 우위 소견은 급성 스트레스 반응 및 심근경색에 동반된 염증반응으로 해석 가능하나, 감염원의 동반 여부는 임상적 판단이 필요함.						
3. 젖산 상승 및 대사성 산증 소견이 관찰되므로 조직 관류 상태에 대한 지속적 모니터링을 권고함.						
4. HbA1c 7.4%로 장기 혈당 조절이 목표치에 미달함. 퇴원 전 내분비내과 협진을 고려할 수 있음.						
※ 본 결과는 응급 검체로 처리되었으며, 임상 소견 및 영상검사와 종합하여 해석하시기 바랍니다. 결과 문의 : 진단검사의학과 검사실 내선 2318 (24시간)						

본 문서는 OCR / 문서인식 모델 테스트를 위해 생성된 가상의 예시 자료이며, 실존하는 환자·의료인·의료기관과 무관합니다.